



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

TERM OF REFERENCE (TOR)
HIPNOTIK SEDATIF
TAHUN 2025



**TOR (TERM OF REFERENCE)
PELATIHAN SEDASI
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hipnotik sedatif adalah istilah untuk obat-obatan yang mampu mendepresi sistem saraf pusat. Sedatif adalah substansi yang memiliki aktifitas moderate yang memberikan efek menenangkan, sementara hipnotik adalah substansi yang dapat memberikan efek mengantuk dan yang dapat memberikan onset serta mempertahankan tidur.

Beberapa macam obat dalam dunia kedokteran, seperti magadom digunakan sebagai zat penenang (sedativa-hipnotika). Pemakaian sedativa-hipnotika dalam dosis kecil dapat menenangkan, dan dalam dosis besar dapat membuat orang yang memakainya tertidur. Gejala akibat pemakaiannya adalah mula-mula gelisah, mengamuk lalu mengantuk, malas, daya pikir menurun, bicara dan tindakan lambat. Jika sudah kecanduan, kemudian diputus pemakainya maka akan menimbulkan gejala gelisah, sukar tidur, gemetar, muntah, berkeringat, denyut nadi cepat, tekanan darah naik, dan kejang-kejang. Jika pemakainya overdosis maka akan timbul gejala gelisah, kendali diri turun, banyak bicara, tetapi tidak jelas, sempoyangan, suka bertengkar, napas lambat, kesadaran turun, pingsan, dan jika pemakainya melebihi dosis tertentu dapat menimbulkan kematian.

Penggunaan klinis kedua golongan obat-obatan ini telah digunakan secara luas seperti untuk tata laksana nyeri akut dan kronik, tindakan anestesia, penatalaksanaan kejang, serta insomnia. Pentingnya penggunaan obat-obatan ini dalam tindakan anestesi memerlukan pemahaman mengenai farmakologi obat-obatan kedua obat. Hal tersebut yang mendasari penulisan mengenai farmakologi obat-obatan hipnotik sedatif.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 3.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Pelatihan sedasi diRS diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai teknik dan prinsip sedasi yang aman
2. Tujuan
 - a. Tujuan Umum
Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu mengaplikasikan apa yang didapat dari pelatihan hipnotik sedatif ini dalam kegiatan pelayanan di RS Prima Husada Malang.
 - b. Tujuan Khusus
 - a) Keselamatan pasien



- b) Meminimalkan rasa sakit dan kecemasan terkait dengan prosedur
- c) Meminimalkan gerakan pasien selama prosedur
- d) Memaksimalkan keberhasilan dari prosedur tindakan CT-scan diruang radiologi dan pasien kembali sadar secepat mungkin
- e)

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 SUSUNAN PANITIA

NO	SUSUNAN PANITIA	NAMA	TUGAS
1	Ketua Panitia	Siti Durotul Ibadiah S. Kep Ns	bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara. Hasil akhir : LPJ
2	Sekretaris	Rendhi adiyatma AMd. Kep	bertanggung jawab terhadap pendokumentasian seluruh dokumen dan notulen. Hasil akhir : 1) notulen 2) LPJ
3	Moderator	Ferry Kuswanto S. Kep Ns	bertanggung jawab sebagai moderator dan mengaktifkan tanya jawab peserta. Hasil akhir: ringkasan persesi dan tanya jawab
4	Absensi	Kiki Sandra AMd.Kep	bertanggung jawab terhadap kelengkapan absensi dan menyiapkan serta membagikan kuesioner pelathan. Hasil akhir: rekap absensi dan kuesioner pelatihan
5	Sie Dokumentasi	Afny Pandyaga Lenny	bertanggung jawab sebagai fotografer. Hasil akhir: foto di LPJ
6	Sie Perlengkapan	Anita sari S. Kep. Ns	bertanggung jawab terhadap kelengkapan peralatan, peminjaman, dan pengembalian alat. Mengambilkan alat-alat yang belum tersedia saat acara
7	Sie Penunjang	Sekretaris RSPH (MONEV : SDM, PKRSRM)	bertanggung jawab mengkoordinir peserta untuk patuh dengan jadwal pelatihan
8	Sie Pretest dan Posttest	Eko pambudi AMd.Kep	bertanggung jawab terhadap pembagian, pelaksanaan, penilaian pre-post test. Hasil akhir : rekap pre-post test

2.2 RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Pelatihan Hipnotik Sedatif RS Prima Husada Malang Tahun 2025 Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Tanggal : 24 Desember 2025

Waktu : 10.00 s/d 12.00 WIB

Tempat : Hall Sakura Lantai 5 RS Prima Husada Malang

2.3 RENCANA RAPAT PANITIA PENYELENGGARAAN

JUDUL MATERI	SASARAN	NARASUMBER	METODE	PERLENGKAPAN	FREKUENSI PELAKSANAAN	DASAR MATERI	OUTPUT TRAINING	TARGET TRAINING JANGKA PANJANG
Pelatihan sedatif	1. Perawat 2. Bidan	dr. Arif Heru Sp. An	1. Pre-Post Test 2. Presentasi 3. Diskusi 4. Tanya Jawab	a. LCD b. Laptop c. Sound system d. Alat Tulis	1x / tahun	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 3 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit	1. Tenaga kesehatan mampu mengenali tingkat sedasi yang tepat (minimal, moderat, atau dalam). 2. Mampu melakukan pemantauan tanda vital dan respons pasien selama prosedur 3. Adanya alur kerja (SOP) sedasi yang konsisten diruangan 4. Penggunaan checklist sedasi sebelum, selama, dan setelah tindakan 5. Pencatatan evaluasi pra-sedasi, obat yang diberikan, monitoring, serta evaluasi pasca-sedasi menjadi lebih lengkap dan akurat.	1. Seluruh unit yang melakukan prosedur sedasi mengikuti standar yang sama (SOP, protokol, checklist) 2. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu mengaplikasian apa yang didapat dari pelatihan hipnotik sedatif ini dalam kegiatan pelayanan 3. Seluruh tenaga yang terlibat memiliki kompetensi tersertifikasi (mis. airway management, monitoring, penanganan kegawat daruratan).

Outline Training

NO	OUTLINE	ISI PPT	PJ
1	Barcode absensi	QR code absensi	MC
2	Pre test	QR code pre test dengan waktu (estimasi 30 detik / pertanyaan)	MC
3	Susunan acara	Tabel rundown acara training	MC
4	Judul	Pelatihan Hipnotik Sedasi	Narsum
5	Latar Belakang	Pelaksanaan sedasi diRS merupakan prosedur medis yang memiliki resiko tinggi terhadap jalan nafas. Oleh karena itu diperlukan tenaga kesehatan yang kompeten, ruangan dan alat yang memenuhi standar. Namun masih ditemukan fasilitas ruangan ,alat yang belum memenuhi standar dan belum adanya SOP pelaksanaan sedasi.	Narsum
6	Target	1. Perawat, dan bidan memahami indikasi dan kontra indikasi sedasi 2. Perawat, dan bidan memahami persiapan alat, obat, serta mengidentifikasi alur prosedur 3. Perawat, dan bidan memahami tehnik monitoring selama sedasi (SPO2, RR, TD) 4. Perawat, dan bidan memahami komplikasi terhadap sedasi (hipotensi, depresi nafas, reaksi alergi) 5. Perawat, dan bidan memahami, menetapkan kreteria pemulihan yang aman	Narsum
7	Konsep dasar sedasi	1. Definisi sedasi dan tujuan penggunaannya 2. Tingkatan sedasi (minimal, moderat, dalam) 3. Indikasi dan kontra indikasi sedasi 4. Perbedaan sedasi dan anastesi umum	Narsum
8	Farmakologi obat sedasi	1. Jenis obat sedasi yang umum digunakan 2. Mekanisme kerja dan metabolisme obat 3. Efeksamping dan tanda over sedasi 4. Faktor resiko	Narsum
9	Penilaian pra-sedasi	1. Penilaian status fisik 2. Riwayat medis, alergi dan obat yang dikonsumsi 3. informed	Narsum
10	Persiapan sedasi	1. persiapan alat dan obat emergensi 2. persiapan ruangan, oksigen, suction, airway tools 3. persiapan pasien puasa 6 jam 4. peran tim sedasi	Narsum

11	Tehnik dan prosedus sedasi	1. Alur pelaksanaan sedasi 2. Pemberian sedasi sesuai target level 3. Monitoring pasien selama tindakan 4. Dokumentasi selama prosedur	Narsum
12	Kesimpulan	Penekanan pada hal-hal yang harus dilakukan setelah ini	MC
13	Post Test	QR code post test dengan waktu (estimasi 30 detik / pertanyaan)	MC

Rapat : Pre Training : Materi/ Bahasan Alur Persiapan dan Pelaksanaan Training

NO	LANGKAH	PJ	YANG TERLIBAT
Pre Training			
1	Mendiskusikan materi yang akan diberikan untuk training (materi berdasarkan outline training)	Siti Durotul Ibadiyah S. Kep Ns	Komite Keperawatan & Kebidanan Hasil materi di CC ke SDM
2	Pembuatan soal pre/post test & kunci jawaban	Siti Durotul Ibadiyah S. Kep Ns	
3	Pembuatan PPT berdasarkan materi yang sudah didiskusikan	dr. Arif Heru Sp. An	Narasumber
4	Pengumpulan PPT materi maksimal H-7 acara	dr. Arif Heru Sp. An	Narasumber
5	Menentukan moderator training	Siti Durotul Ibadiyah S. Kep Ns	PJ Bab PAB
6	Menyusun panitia (MC merangkap dokumentasi, IT sebagai operator)	Siti Durotul Ibadiyah S. Kep Ns	PJ Bab PAB
7	Membuat / membahas Form Evaluasi penyelenggara untuk narasumber	Siti Durotul Ibadiyah S. Kep Ns	PJ Bab PAB
8	Media apa saja yang perlu disiapkan agar diklat berjalan sesuai tujuan dan harapan	Siti Durotul Ibadiyah S. Kep Ns	PJ Bab PAB
9	Penyusunan slide host (PPT yang ditampilkan sejak awal mulai dari absensi, pre test, rundown, ppt materi, post test dijadikan 1 kesatuan)	Siti Durotul Ibadiyah S. Kep Ns	Panitia

2.4 SASARAN ATAU PESERTA

NO	PROFESI	JUMLAH
1	Perawat	143
2	Bidan	31
TOTAL		174

2.5 SUSUNAN ACARA LENGKAP

Rundown kegiatan

JAM	DURASI	MATERI	PEMATERI
Gelombang I			
08.00-08.15 WIB	15 menit	Pretest	Tim
08.15-09.45 WIB	60 menit	1. Definisi dan tujuan sedasi 2. Indikasi dan kontraindikasi 3. Tingkatan sedasi 4. Efek samping obat-obatan sedasi 5. Pelaksanaan dan kreteria pemulihan sedasi	dr. Arif Heru Sp. An
		6. Komplikasi 7. Standar dan regulasi diRS 8. Peralatan emergensi sedasi 9. Kesimpulan	
	30 menit	Tanya Jawab	Tim
09.45-10.00 WIB	15 menit	Post test	Tim
Gelombang II			
14.00-14.15 WIB	15 menit	Pretest	Tim
14.15-15.45 WIB	60 menit	1. Definisi dan tujuan sedasi 2. Indikasi dan kontraindikasi 3. Tingkatan sedasi 4. Efek samping obat-obatan sedasi 5. Pelaksanaan dan kreteria pemulihan sedasi 6. Komplikasi 7. Standar dan regulasi diRS 8. Peralatan emergensi sedasi 9. Kesimpulan	dr. Arif Heru Sp. An
	30 menit	Tanya Jawab	Tim
15.45-16.00 WIB	15 menit	Post test	Tim

2.6 NARASUMBER

1. dr. Arief heru Sp.An

2.7 MEDIA

1. LCD
2. Laptop
3. Sound system

2.8 METODE

1. Pre-Post Test
2. Presentasi
3. Diskusi
4. Tanya Jawab



2.9 KEBUTUHAN ANGGARAN

NO.	RINCIAN KEBUTUHAN	JUMLAH	SATUAN (RP)	HARGA (RP)	SUMBER DANA
1	Snack pameri	2 kardus	Rp 20.000	Rp 40.000	Dapur RSPHM
2	Aqua botol	2 botol	Rp 5.000	Rp 10.000	Dapur RSPHM
3	Aqua gelas	4 dus	Rp 25.000	Rp 100.000	Dapur RSPHM
4	Sertifikat	174	Rp 0	Rp 0	Internal Cetak Soft copy oleh SDM
Total				Rp 150.000	
Yang diajukan kepada PT Disa Prima Medika				Rp 150.000	

III. MONITORING – EVALUASI

3.1 MONITORING

NO	BAHASAN DAN KEGIATAN	PJ	YANG TERLIBAT/ YANG MASUK PANITIA
1	Memastikan training berjalan sesuai TOR dan rundown	SDM	PJ Training
2	Mencatat evaluasi yang ditemukan selama training berjalan	SDM	PJ Training
3	Memimpin evaluasi setelah training selesai	SDM	PJ Training
4	Mengirimkan link g-form evaluasi yang diisi oleh narasumber	SDM	Narasumber
5	Menyiapkan kredensial apabila materi training ada sesi praktek / role play	SDM	Ketua Komite terkait

3.2 EVALUASI

EVALUASI (POST TRAINING) JANGKA PENDEK			
1	Merekapitulasi hasil nilai pre test dan post test	Eko pambudi AMd.Kep	Panitia
2	Melakukan evaluasi hasil penilaian baik untuk penyelenggara maupun untuk narasumber dan pengamatan perilaku peserta saat diklat (serius, mengantuk, antusias)	Eko pambudi AMd.Kep	Panitia
3	Menerbitkan sertifikat	SDM	SDM
4	Evaluasi kinerja panitia	SDM	SDM

EVALUASI (POST TRAINING) JANGKA PANJANG			
1	Melakukan supervisi atau observasi kepatuhan peserta diklat terhadap regulasi dan materi-materi dalam diklat yang sudah diikuti	Siti Durotul Ibadiyah S. Kep Ns	SDM dan PJ Bab PAB
2	Hasil supervisi dibahas di rapat koordinasi	Siti Durotul Ibadiyah S. Kep Ns	PJ Bab PAB
3	Membuat RTL-TL-Evaluasi secara berkala	Siti Durotul Ibadiyah S. Kep Ns	PJ Bab PAB



IV. PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Untuk mempertahankan nilai Akreditasi Rumah Sakit yang Paripurna. Oleh karena itu dukungan semua pihak sangat penting dalam keberhasilan acara ini.

Mengetahui,
SDM RS Prima Husada Malang

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Malang, 15 Desember 2025
Ketua Panitia,

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Susan Rahmawati, S.Sos

Ns. Siti Durotul Ibadiyah, S.Kep

Disetujui oleh,
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes